

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA BREVE DE ANSIEDAD DE TYRER (BSA)

Brief Scale for Anxiety (Tyrer, Owen & Cicchetti, 1984) · Subescala de la CPRS · Adaptación Española (Bobes et al., 2004)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala Breve de Ansiedad de Tyrer (Brief Scale for Anxiety, BSA)
Sigla / Acrónimo	BSA (CPRS-A en literatura europea)
Autoría original	Peter Tyrer, R. T. Owen & Domenic V. Cicchetti (1984, J Neurol Neurosurg Psychiatry)
Marco de procedencia	Subdivisión empírica de la CPRS (Comprehensive Psychopathological Rating Scale) de Åsberg et al.
Adaptación en español	Bobes García, García-Portilla, Bascarán, Sáiz et al. (2004, Banco de Instrumentos / CIBERSAM)
Constructo evaluado	Intensidad y gravedad clínica de la ansiedad patológica aislada y no contaminada por depresión
Población diana	Adultos con trastornos de ansiedad, estrés agudo, cuadros adaptativos o patología médica con ansiedad
Tiempo de aplicación	10 a 15 minutos (heteroadministrada mediante entrevista clínica semiestructurada)
Estructura y formato	10 ítems evaluados en escala de 0 a 6 puntos con anclajes clínicos descriptivos detallados
Condiciones de uso	Dominio público para práctica asistencial e investigación académica citando a Tyrer et al. (1984)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Una de las dificultades psicométricas y conceptuales más notorias en la evaluación de la ansiedad es su elevado solapamiento con los síntomas depresivos en las escalas tradicionales (como la HARS de Hamilton). Para resolver este problema de especificidad, Peter Tyrer y colaboradores extrajeron de la extensa escala psicopatológica CPRS un conjunto selecto de 10 ítems que demostraron en análisis discriminantes una independencia empírica robusta respecto al afecto depresivo.

El modelo teórico de la BSA distingue nítidamente dos componentes nucleares: la **ansiedad psíquica** (el componente cognitivo y emocional de aprensión, preocupación mórbida y sensación subjetiva de miedo) y la **ansiedad somática/autonómica** (las descargas neurovegetativas periféricas, la tensión muscular y la hiperactividad simpática). Su escala graduada de 0 a 6 puntos proporciona una extraordinaria sensibilidad al cambio psicofarmacológico.

3. LOS 10 ÍTEMES CLÍNICOS DE LA ESCALA BSA

Ítem	Síntoma Clínico Evaluado	Rango	Dimensión Psicofisiológica
1	Ansiedad interior (sensación subjetiva de tensión)	0 - 6	Ansiedad psíquica / distrés interior
2	Pensamientos hostiles e irritabilidad fóbica	0 - 6	Repercusión cognitiva y relacional
3	Ansiedad fóbica ante situaciones externas	0 - 6	Componente fóbico situacional
4	Deterioro del sueño de conciliación	0 - 6	Insomnio de hiperarousal nocturno
5	Dolor o molestias precordiales / disnea suspirosa	0 - 6	Somatización torácica autonómica
6	Palpitaciones y taquicardia refleja	0 - 6	Hiperreactividad cardiovascular
7	Sudoración profusa y sofocos vasomotores	0 - 6	Desregulación sudomotora simpática
8	Mareo, inestabilidad y vértigo psicógeno	0 - 6	Alteración vestibular / hiperventilación
9	Tensión muscular y cefaleas opresivas	0 - 6	Hipertonía motora periférica
10	Pérdida de concentración y lapsus por angustia	0 - 6	Sobrecarga cognitiva atencional

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y ESPECIFICIDAD CLÍNICA

Consistencia interna	Excelente consistencia global; alfa de Cronbach $\alpha = 0.88 - 0.91$ en muestras ambulatorias psiquiátricas con trastornos de ansiedad (Bobes et al., 2004).
Fiabilidad interjueces	Elevada concordancia entre evaluadores psiquiátricos independientes; coeficiente de correlación intraclass CCI = $0.85 - 0.92$.
Validez discriminante	Demuestra una capacidad de discriminación superior frente a la depresión que la escala de Hamilton (HARS); correlación modesta con la escala de melancolía MADRS ($r = 0.38$).
Validez concurrente	Correlación positiva robusta con la Escala de Ansiedad de Hamilton (HARS, $r = 0.84$) y con el inventario STAI-Estado ($r = 0.79$).
Sensibilidad al cambio	Muestra caídas inmediatas y estadísticamente significativas ($p < 0.001$) tras la instauración de ansiolíticos y terapia cognitivo-conductual.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Escala de gravedad 0-6	Cada ítem se califica con valores pares definidos operativamente (0 = ausente, 2 = leve, 4 = moderado, 6 = severo incapacitante); los valores impares (1, 3, 5) se usan para grados intermedios.
Puntuación directa total	Suma aritmética directa de los 10 ítems. Rango teórico posible: 0 a 60 puntos . No existen ítems invertidos.
Desglose subdimensional	Ansiedad Psíquica = suma ítems 1, 2, 3, 4, 10 (rango 0-30); Ansiedad Somática = suma ítems 5, 6, 7, 8, 9 (rango 0-30).
Marco temporal evaluado	La exploración evalúa la gravedad y frecuencia de las manifestaciones ansiosas durante los últimos 3 días .

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación BSA	Percentil Aprox.	Nivel de Ansiedad	Significación Clínica y Pronóstico
0 - 7 puntos	< Pc 50	Ansiedad Normal / No Clínica	Ausencia de sintomatología ansiosa clínicamente relevante.
8 - 14 puntos	Pc 55 - Pc 74	Ansiedad Leve	Malestar reactivo situacional; seguimiento y medidas de higiene mental.
15 - 27 puntos	Pc 75 - Pc 89	Ansiedad Moderada	Cuadro de ansiedad estructurado; indicación formal de tratamiento activo.
28 - 60 puntos	>= Pc 90	Ansiedad Grave / Incapacitante	Parálisis funcional severa; alta interferencia autonómica y cognitiva.

PUNTOS DE CORTE CANÓNICOS (TYRER ET AL.):

- **BSA ≥ 15 puntos:** Umbral óptimo de positividad que define un trastorno de ansiedad clínicamente significativo que requiere intervención profesional.
- **Criterio de Remisión Posterapéutica:** Puntuación final < 8 puntos o reducción de al menos el 50% de la puntuación basal.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE MANEJO FARMACOLÓGICO Y PSICOTERAPÉUTICO

Paso 1: Aplicación de la entrevista BSA: Calcular puntuación total (0-60) y balance psíquico/somático.

Paso 2: Si predomina Ansiedad Somática (ítems 5 a 9 elevados):

- Descartar causas orgánicas (hipertiroidismo, arritmias paroxísticas, feocromocitoma).
- Si se confirma base funcional: entrenamiento en respiración diafragmática y relajación muscular progresiva; valorar betabloqueantes o pregabalina.

Paso 3: Si predomina Ansiedad Psíquica (ítems 1 a 4 y 10 elevados):

- TCC focalizada en reestructuración de distorsiones catastróficas e intolerancia a la incertidumbre.
- Fármacos de mantenimiento: ISRS (escitalopram, sertralina) o IRSN (venlafaxina); restringir benzodiacepinas a pautas agudas de rescate (< 3 semanas).

Paso 4: Reevaluación: Aplicar la BSA cada 15-30 días para evaluar desescalada farmacológica cuando se alcance la remisión (< 8).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN ATENCIÓN MÉDICA INTEGRADA

Identificación: Paciente varón de 44 años, auditor contable, atendido en interconsulta tras acudir a Urgencias en tres ocasiones en el último mes por palpitaciones violentas, sudoración fría y sensación de opresión precordial durante el cierre fiscal. ECG, troponinas y ecocardiograma normales.

Evaluación BSA Inicial: Puntuación Total = **32 / 60** (Ansiedad Grave).

- Ansiedad Psíquica = 14/30 (Ítem 1 Tensión interna = 5, Ítem 4 Insomnio = 4, Ítem 10 Concentración = 3).
- Ansiedad Somática = 18/30 (Ítem 5 Opresión torácica = 4, Ítem 6 Palpitaciones = 5, Ítem 7 Sudoración = 4, Ítem 8 Mareo = 3).

Diagnóstico: Trastorno de Pánico con Agorafobia incipiente y predominio de hiperreactividad somatovegetativa.

Intervención: Psicoeducación en hiperventilación y circuito del pánico; inicio de sertralina 50 mg/día asociada a pauta breve de lorazepam 0.5 mg/noche durante 10 días y entrenamiento en coherencia cardíaca.

Reevaluación a las 6 semanas: La BSA Total cayó a **6 / 60** (Remisión clínica completa, reducción de 26 puntos), con normalización de la esfera somatovegetativa y retorno a la actividad laboral plena.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos Médicos:

- **Sintomatología Precordial Aguda:** Descartar siempre síndrome coronario agudo mediante ECG y marcadores enzimáticos antes de catalogar el dolor torácico como "ansioso".
- **Abuso de Benzodiacepinas:** Riesgo severo de tolerancia y dependencia en pacientes con puntuaciones altas crónicas.

Diagnóstico Diferencial:

- **Depresión Mayor con Agitación:** En la depresión melancólica la culpa y el dolor moral son el núcleo primario; la BSA se mantiene baja en desesperanza.
- **Patología Tiroidea:** El hipertiroidismo mimetiza casi todos los ítems somáticos de la BSA (palpitaciones, sudor, temblor).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Tyrer, P., Owen, R. T., & Cicchetti, D. V. (1984). The brief scale for anxiety: a subdivision of the comprehensive psychopathological rating scale. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 47(9), 970-975. <https://doi.org/10.1136/jnnp.47.9.970>
- Åsberg, M., Montgomery, S. A., Perris, C., Schalling, D., & Sedvall, G. (1978). A comprehensive psychopathological rating scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica. Supplementum*, 271, 5-27.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
- Tyrer, P. (1990). The division of neurosis: a tracking experiment in taxonomy. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 83(10), 614-617.